

## 关于甲状腺功能减退症对健康影响的探析

广西医科大学附设玉林卫生学校附属医院 邓云

甲状腺功能减退症,简称甲减,是一种机体甲状腺激素合成或分泌减少,或生物学效应不足而导致的内分泌疾病。甲减可累及全身各个系统,是一种临床综合征,其表现为机体代谢活动及各系统功能下降。甲减是一种较为常见的内分泌疾病其症状往往不典型且多样化

### 甲状腺功能减退相关症状

甲状腺功能减退起病缓慢,一般多表现为代谢减慢症候群。患者会出现怕冷、无汗、体温低于正常等症状,还可能出现水肿面容、表情淡漠呆板、反应迟钝、口唇增厚、舌体肥大、说话慢而不流利、言语少、语音粗显等症状。毛发稀疏易脱落,指甲厚而脆。皮肤因贫血、维生素 A 合成障碍致血中胡萝卜素含量增高而呈苍黄色,粗糙、无光泽,脱屑。皮下脂肪因水分的积聚而增厚,使体重增加。严重甲减者会发生黏液性水肿,典型者表现为神情淡漠、面色苍白,眼睑水肿,唇厚舌大,皮肤蜡黄、干燥脱屑,毛发稀疏脱落,特征性的非凹陷性水肿(黏液性水肿)等。随着病情的进一步发展,可能会出现多个系统和器官功能减退的症状。

在神经系统方面,表现为理解力及记忆力下降,智力减退;嗜睡,精神迟钝,可呈神经质或出现幻觉、妄想;严重者出现精神分裂。

心血管系统会出现心动过缓,心血输出量减少,心音低钝,心脏扩大,常伴有心包积液。

消化系统常出现厌食、腹胀、便秘,严重者可出现黏液水肿性巨结肠症及麻痹性肠梗阻。

内分泌系统表现为女性月经过多,闭经等;男性勃起功能障碍,性欲减退。少数患者出现泌乳,继发性垂体增大。当病情严重时,可出现甲减危象,表现为低体温,呼吸减慢,心动过缓,血压下降,四肢肌力减退,反射减弱或消失,甚至昏迷、休克,心肾功能衰竭。

不同年龄的人出现甲减,其症状也存在差异。幼年型甲减主要表现为身材矮小,智力低下,性发育延迟。呆小病主要表现为表情呆滞,颜面苍白,眼周浮肿,两眼眼距增宽,鼻梁扁塌,唇厚流涎,舌大外伸四肢粗短,走鸭步。而老年性甲减起病隐匿,神情淡漠、抑郁、怕冷是最常见的症状。

### 如何早期发现甲状腺功能减退

如果孩子出生后 3 至 6 个月出现喂奶困难、便秘、哭声嘶哑、嗜睡、生长缓慢等情况,之后逐渐出现腹胀或腹部膨隆、皮肤干燥、头发及指甲生长迟缓,父母应警惕孩子是否患了呆小病,要及时带孩子去医院检查甲状腺功能。

甲状腺功能减退症通常比较隐匿且进展缓慢。成年人可能出现乏力、困倦、怕冷、便秘等症状,尤其是成年女性出现月经增多等情况,数月或数年后出现反应迟钝、神情淡漠、毛发脱落、声音嘶哑、食欲不振或厌食、体重增加及皮肤粗糙等症状。严重者会黏液性水肿,神情淡漠、眼睑及面颊水肿、面色苍白或蜡黄、舌增大及唇增厚等症状。此时应及时去医院检查甲状腺功能。如果甲状腺激素指标 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>、游离 T<sub>3</sub>(FT<sub>3</sub>)、游离 T<sub>4</sub>(FT<sub>4</sub>)低于正常值,而促甲状腺激素(TSH)高于正常值,可诊断为甲状腺功能减退症。

### 如何治疗甲状腺功能减退

对于甲状腺功能减退症的治疗,主要包括甲状腺激素替代治疗和病因治疗。甲状腺功能减退症是由于机体甲状腺激素缺乏引起的,因此需要用甲状腺激素替代治疗。补充甲状腺激素制剂后,不仅能够迅速起效,而且疗效显著。继续服用适量的甲状腺激素制剂,还有利于患者稳定病情。临床上常用的甲状腺激素制剂有甲状腺片、左甲状腺素钠(LT<sub>4</sub>)。

对于有病因的患者,应进行病因治疗。如缺碘性甲状腺功能减退症给予补碘,高碘化物引起的甲状腺功能减退症应停用碘化物;药物导致的甲状腺功能减退症,药物减量或停用后,甲状腺功能减退症可自行消失;锂盐治疗精神病有 3%至 4%发生甲状腺功能减退症的概率,停药可好转;丘脑或垂体有肿瘤的患者,行肿瘤切除术后甲状腺功能减退症有可能得到不同程度的改善;亚急性甲状腺炎、无痛性甲状腺炎、一过性甲状腺功能减退症,随原发病治愈后,甲状腺功能减退症也会消失。

此外,甲状腺功能减退症药物替代疗程应根据其发生是暂时性的还是永久性的来决定。如因服用抗甲状腺药物导致的甲状腺功能减退症,则为暂时性的,只要减量或停药,并加用甲状腺激素,短期内就可好转。慢性淋巴细胞性甲状腺炎患者,早期可发生甲状腺功能亢进症,后期多出现甲状腺功能减退症,也可能甲状腺功能亢进症、甲状腺功能减退症交替出现,此时需密切观察病情,监测 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>、促甲状腺激素以确定治疗方案。采用手术、碘-131 治疗甲状腺功能亢进症,其导致的甲状腺功能减退症多属于永久性甲状腺功能减退症,替代治疗也应长期进行。

总之,甲状腺功能减退症对健康的影响不容忽视,应提高对其的认识,进行积极预防,做到早发现、早治疗,以减少其对健康的危害。